

L'approche FASTR

Des analyses à cycle rapide pour accélérer les progrès de la SRMNEA-N

»» FASTR Useful Data

OBJECTIF

Les analyses à cycle rapide accélèrent les progrès de la SRMNEA-N en renforçant la disponibilité et l'utilisation systématique et opportune des données pour la prise de décisions stratégiques.

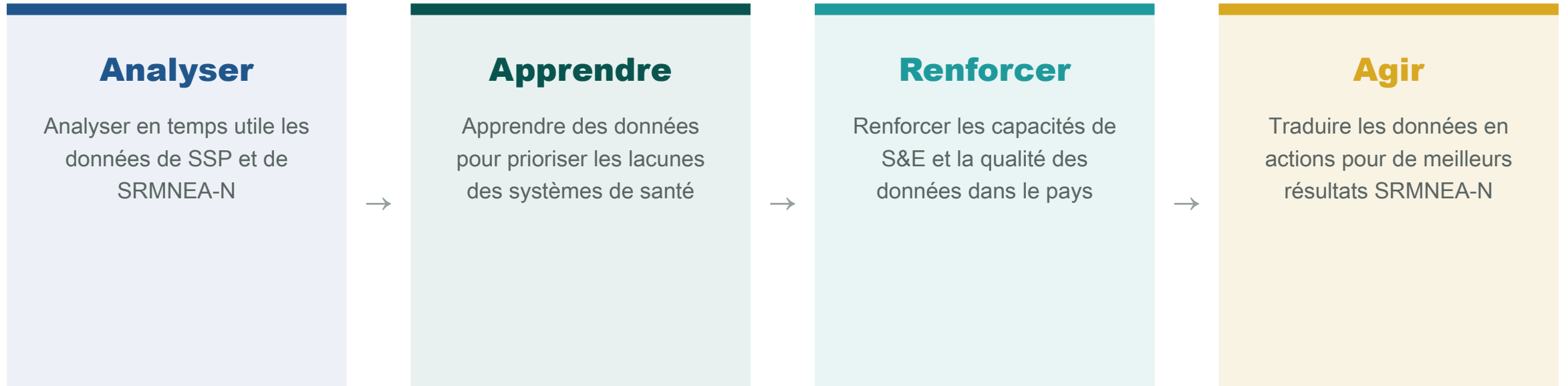
Qu'est-ce que FASTR ?

Le GFF soutient les efforts menés par les pays pour améliorer la génération et l'utilisation, en temps utile, des données pour la prise de décision — afin de renforcer les systèmes de soins de santé primaires (SSP) et d'améliorer les résultats en matière de SRMNEA-N.

Cet ensemble d'initiatives et d'appui technique est désigné sous le nom de **Frequent Assessments and System Tools for Resilience (FASTR)**.

FASTR catalyse des cycles continus d'**analyse, apprentissage, renforcement et action** pour ancrer l'utilisation systématique des données dans la décision.

Un cycle continu



...et le cycle recommence, trimestre après trimestre.

Comment y parvenons-nous ?

FASTR propose un ensemble d'approches **rigoureuses, rapides et peu coûteuses** pour le suivi et l'évaluation des systèmes de soins de santé primaires.

Elles s'accompagnent d'un **renforcement des capacités** et d'un **soutien à l'utilisation des données**, adaptés aux besoins du pays.

PARTIE 1

**Une approche intégrée : quatre piliers
complémentaires**

Quatre piliers complémentaires

01

Utilisation des services SRMNEA-N

Exploiter les données du SNIS pour suivre l'évolution de la couverture des services — en période de réforme, de choc ou au sein des populations vulnérables — tout en corrigeant les problèmes de qualité des données.

02

Enquêtes auprès des formations sanitaires

Évaluer les lacunes dans la prestation des soins de santé primaires et comprendre l'impact des réformes ou des chocs sur la performance des systèmes de santé.

03

Enquête auprès des ménages et des usagers

Fournir un aperçu de l'utilisation des services, du renoncement aux soins, et des perceptions communautaires de la qualité des services.

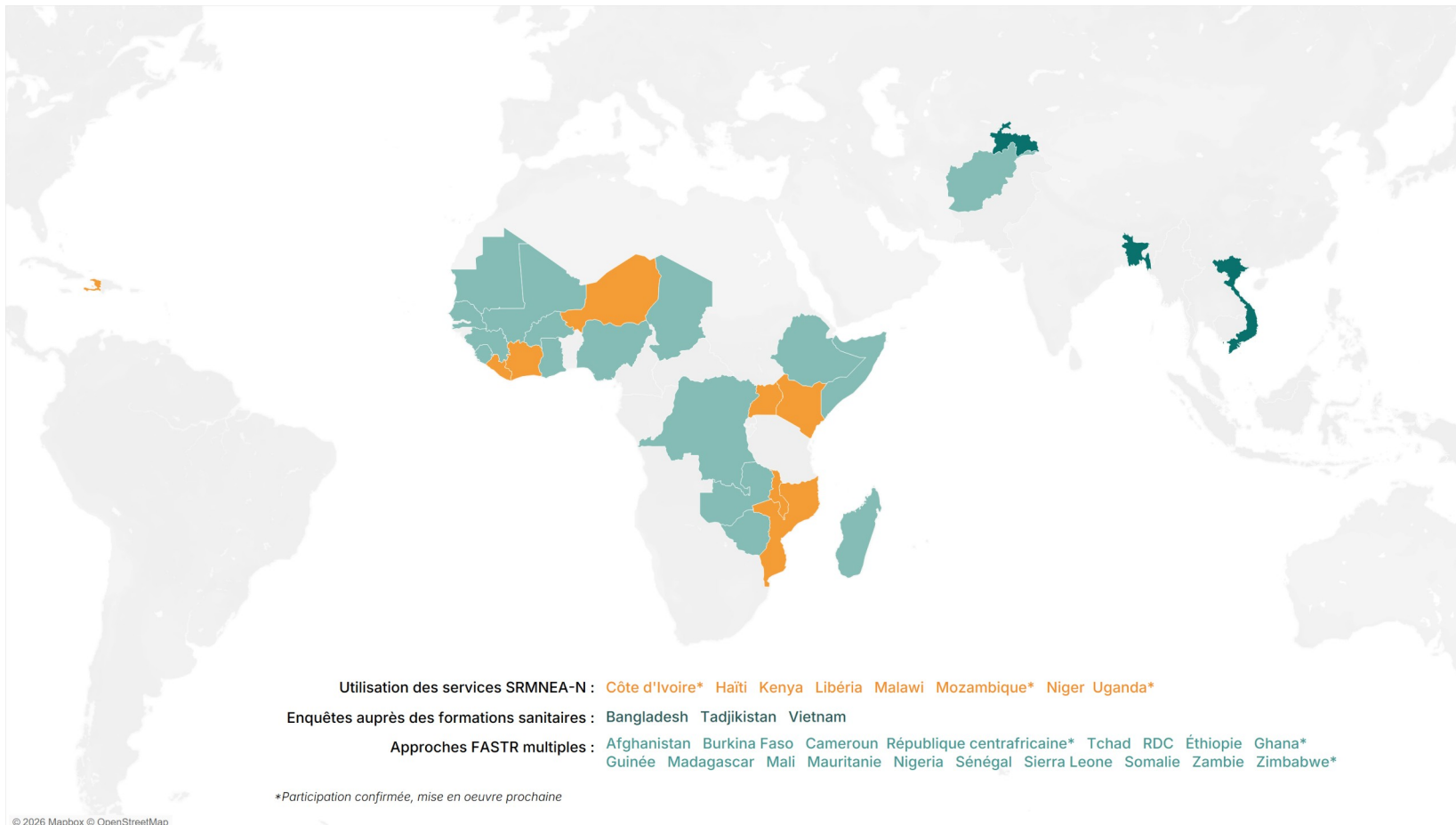
04

Études qualitatives rapides

Mieux comprendre les enjeux émergents des systèmes de santé à travers des approches mixtes, rapides et flexibles.

Transversal Renforcement des capacités et soutien à l'utilisation des données

FASTR est opérationnel dans 29 pays partenaires du GFF — et continue de se développer



PARTIE 2

Enquêtes rapides auprès des formations sanitaires

Quelle est l'approche FASTR ?

Nous concevons et mettons en œuvre des **enquêtes téléphoniques trimestrielles** auprès des formations sanitaires primaires.

Elles produisent des analyses régulières de la performance des soins de santé primaires, de la disponibilité et de la capacité opérationnelle des services, sur des indicateurs prioritaires liés au plan stratégique SRMNIA-N.

Ces résultats informent la prise de décision et des actions concrètes pour renforcer le système de santé.

Ce que l'enquête permet

01

Contraintes de l'offre

Comprendre les contraintes liées à l'offre de services dans les établissements de SSP.

02

Mise en œuvre des réformes

Mesurer la mise en œuvre des réformes sur le terrain.

03

Effet des chocs

Évaluer l'effet des chocs externes sur les systèmes de santé.

04

Gestion adaptative

Améliorer la rapidité et la pertinence des enquêtes comme outil de gestion adaptative.

Un outil structuré et adaptable

Structure

- **10 modules** d'enquête basés sur le cadre **PHCMFI de l'OMS**
- Questions inspirées des outils **HHFA/SARA, SPA et SDI**

Outil d'enquête 100 % adaptable par les pays.

Modules de l'outil d'enquête

- Chocs externes
- Résilience aux chocs
- Offre de services
- Infrastructure
- Financement
- Ressources humaines
- Fournitures médicales
- Direction et coordination
- Participation communautaire
- Amélioration de la qualité des soins

Conception de l'enquête — exemple du Burkina Faso

Modalités de mise en œuvre et méthodologie définies par les pays.

Paramètre	Détail
Modalité	Enquête téléphonique auprès des représentants des formations sanitaires.
Durée	30–45 minutes par appel.
Fréquence	Trimestrielle. L'outil est complété après 4 cycles d'enquête.
Échantillon	Panel représentatif de formations sanitaires primaires. Les mêmes formations sont suivies au cours de l'année.
Échantillonnage	Représentativité nationale ou infranationale selon les besoins du pays (≈ 200–800 formations par pays).
Mise en œuvre	Gouvernement, partenaire académique/technique ou cabinet privé, selon le contexte et la source de financement.
Adaptation rapide	Révision éventuelle de l'outil à chaque trimestre selon les résultats et les questions émergentes.

Une assistance technique est disponible pour renforcer les compétences des pays dans la réalisation d'enquêtes téléphoniques rapides.

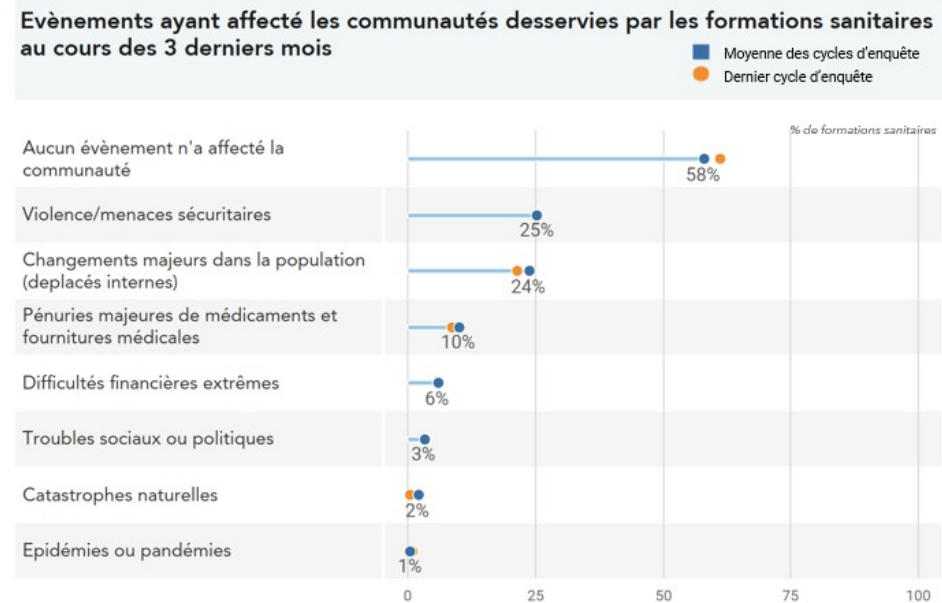
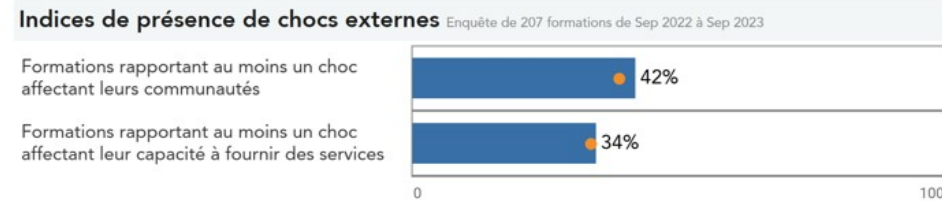
Un contenu qui s'adapte de cycle en cycle

Le contenu évolue à chaque cycle, fournissant de nouvelles perspectives et un apprentissage continu.

Cycle 1	Cycle 2	Cycle 3	Cycle 4
Caractéristiques FOSA	Caractéristiques FOSA*	Caractéristiques FOSA*	Caractéristiques FOSA*
—	Contenu adaptatif**	Contenu adaptatif**	Contenu adaptatif**
Chocs et résilience	Chocs et résilience	Chocs et résilience	Chocs et résilience
Fournitures médicales	Fournitures médicales	Fournitures médicales	Fournitures médicales
Infrastructure	Infrastructure	Infrastructure	Infrastructure
Offre de services	Financement	Amélioration qualité des soins	Ressources humaines
—	Engagement communautaire	—	Leadership et coordination

Modules trimestriels et annuels. *Formations de remplacement uniquement. **Questions supplémentaires identifiées lors de l'adaptation au contexte national ou entre les cycles.

Exemples de résultats — enquête rapide auprès des formations sanitaires



*Les régions prioritaires telles que définies dans le dossier d'investissement du Burkina Faso sont les suivantes: Boucle du Mouhoun, Nord, Centre Nord, Est, Centre Est, et Sahel. [La désagrégation par zone prioritaire vs non-prioritaire et par cycle d'enquête est disponible en annexe \(page 49\).](#)

PARTIE 3

**Analyse de l'utilisation des services
SRMNEA-N**

Quelle est l'approche FASTR ?

Analyses trimestrielles des données DHIS2, axées sur les indicateurs nationaux prioritaires.

Créer des **outils durables** pour que les parties prenantes génèrent les bonnes analyses et visualisations, au bon moment, sur leurs indicateurs d'intérêt.

Combiner analyse et visualisation avec le **renforcement des capacités** et le **soutien à l'utilisation des données**, pour la durabilité et l'institutionnalisation.

Quatre étapes d'analyse

01

Qualité des données

Identifier et corriger les problèmes de qualité pour améliorer la précision de l'analyse.

02

Variations de volume

Quantifier les variations des volumes de services prioritaires au fil du temps.

03

Couverture des services

Comparer les tendances de couverture aux priorités et objectifs du pays.

04

Analyses trimestrielles

Générer des analyses exploitables pour la gestion adaptative.

Évaluation et ajustement de la qualité des données

Overall DQA score

Percentage of facility - months with adequate data quality over time

	2024	2025
Region 001	76.4%	84.4%
Region 002	58.2%	52.0%
Region 003	66.3%	53.2%
Region 004	70.0%	84.9%
Region 005	59.9%	68.2%
Region 006	80.4%	84.2%

- 80% or above
- 70% to 79%
- Below 70%

Adequate data quality is defined as: 1) No missing data or outliers for OPD, Penta1, and ANC1, where available 2) Consistent reporting between Penta1/Penta3 and ANC1/ANC4.

Les évaluations de qualité identifient les problèmes les plus prioritaires.

Elles déterminent les ajustements analytiques nécessaires.

L'objectif : éviter que les problèmes de qualité ne deviennent un obstacle à l'analyse et à l'utilisation des données.

Surveillance des services de santé essentiels

Service volume by year & year-on-year change

Jan 2019 to Sep 2025

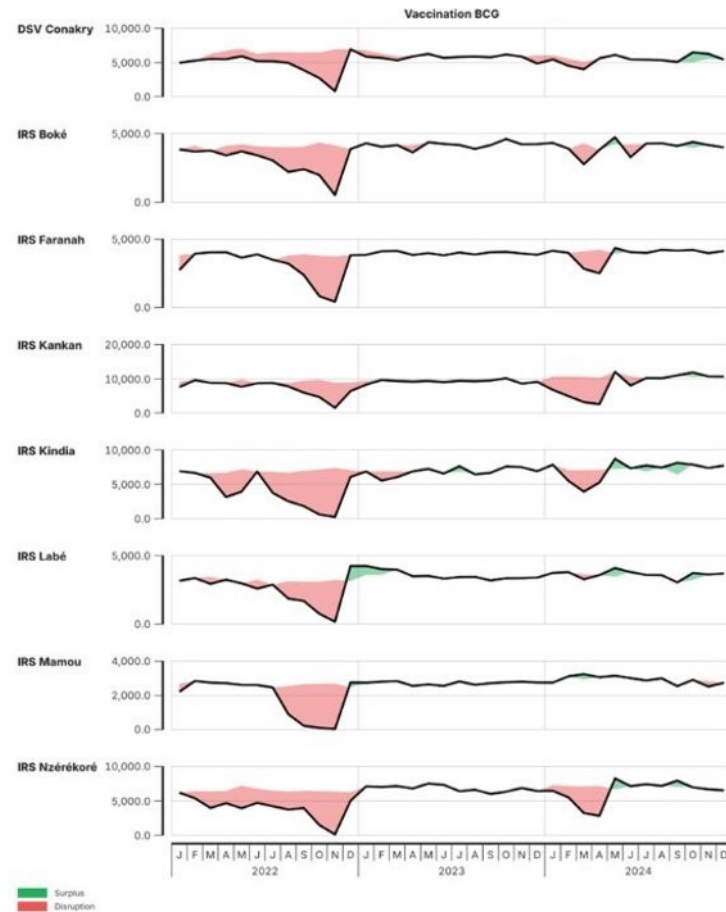


Nous quantifions les variations du volume des services prioritaires :

- le volume annuel absolu des services sélectionnés
- la variation en pourcentage du volume mensuel moyen
- toute année variant de plus de 10 % est signalée
- des variations importantes peuvent indiquer des perturbations, des réformes ou des anomalies de qualité.

Perturbations et excédents de service

Disruptions and surpluses in service volume, sub-nationally
Jan 2022 à Dec 2024



Ce graphique quantifie les variations au niveau du volume de services, par rapport aux tendances historiques, en tenant compte de la saisonnalité. Ces signaux doivent refléter les tendances historiques et la saisonnalité. Les variations inattendues importantes dans les données historiques sont exclues. Cette analyse repose sur une régression

Nous évaluons l'impact des perturbations externes et quantifions l'impact des programmes sur l'utilisation des services.

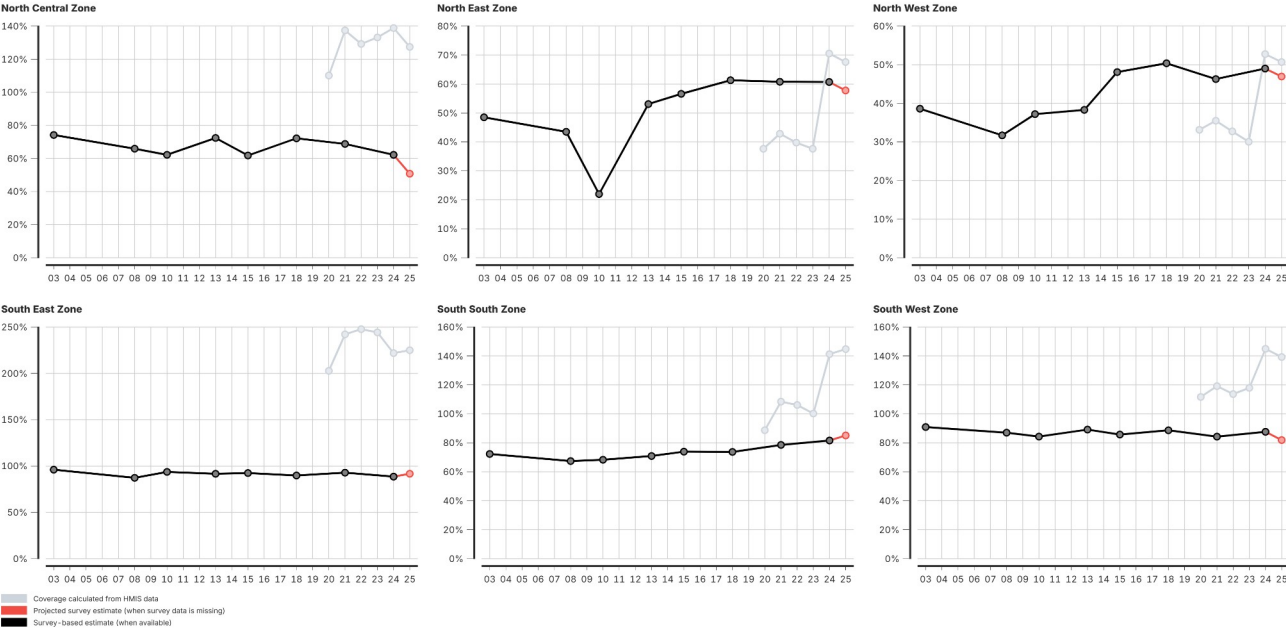
Perturbation — volumes inférieurs aux niveaux prévus : obstacles à l'accès, pénuries de ressources ou défaillances du système.

Excédent — volumes supérieurs aux prévisions : rattrapage, campagnes ou effets de programme.

Couverture du service

Coverage estimates for Antenatal care 1, Nigeria

2003 to 2025
DISCLAIMER: These results use routine data to provide rigorous, but not official estimates. They should be interpreted considering any data quality or representation limitations, including data quality findings and any other country specific factors.



Estimating service coverage from administrative data can provide more timely information on coverage trends, or highlight data quality concerns. Numerators are the volumes reported in HMIS, adjusted for data quality. Denominators are selected from UN projections, survey estimates, or derived from HMIS volume for related indicators. National projections are made by applying HMIS trends to the most recent survey data. Subnational estimates are more sensitive to poor data quality, and projections from surveys are not calculated. MICS data courtesy of UNICEF. Multiple Indicator Cluster Surveys (various rounds) New York City, New York. DHS data courtesy of ICF. Demographic and Health Surveys (various rounds). Rockville, Maryland.

Des méthodes novatrices calculent et valident les dénominateurs de population, améliorant les estimations de couverture issues du SNIS.

Là où les données sont précises : identifier les inégalités infranationales et mettre à jour les estimations obsolètes.

Ailleurs : les tendances observées renseignent tout de même sur la performance globale du système.

PARTIE 4

La plateforme d'analyse et l'assistant IA

Extraction des données

La plateforme FASTR intègre une **importation directe** depuis DHIS2.

C'est souvent la méthode la plus simple, une fois identifiés les indicateurs à inclure.

Pour chaque pays, les données ont déjà été extraites et importées avant l'atelier.

Démonstration (Fr) FASTR

Projets Données Ressources Utilisateurs Paramètres

Ashley Sheffield (Admin)

IMPORTATION EN COURS HMIS Data

1 2 3 4 5

Upload CSV file
Import directly from DHIS2

Save selection

Démonstration (Fr) FASTR

Projets Données Ressources Utilisateurs Paramètres

Ashley Sheffield (Admin)

IMPORTATION EN COURS HMIS Data

1 2 3 4 5

DHIS2 Import Configuration

Enter your DHIS2 connection details to import data.

DHIS2 URL
https://example.dhis2.org

DHIS2 Username
username

DHIS2 Password
password

Save credentials for this session

Confirm and continue

Démonstration (Fr) FASTR

Projets Données Ressources Utilisateurs Paramètres

Ashley Sheffield (Admin)

IMPORTATION EN COURS HMIS Data

1 2 3 4 5

DHIS2 Data Selection

Select indicators to import

INDICATOR ID	LABEL	COMMON IDS
FadFLbD43X	SIS_PEV Penta 3 (0-11 mois)	penta3
IFuAP25ygr	SIS_PEV BCG 0-11 mois	bvg
13CEH46LjRy	SIS_SMR Accouchements assistés par un personnel qualifié	delivery
1Y2cAx20uEw	SIS_SMR Nouvelles femme inscrite en CPN 1	anc1
MOFz4773Gnn	SIS_CUR Contacts ultérieurs	cpd
P8Zgeak038F	SIS_SMR Femmes vues en CPN 4	anc4
r1RSuDuARdy	SIS_PEV Penta 1 0-11 mois	penta1
xzBPoXWwGhB	SIS_CUR Premiers contacts	cpd

Select Period Range

Febr 2025 to Janv 2026

Selected: 0 indicators x 12 periods = 0 data points to fetch

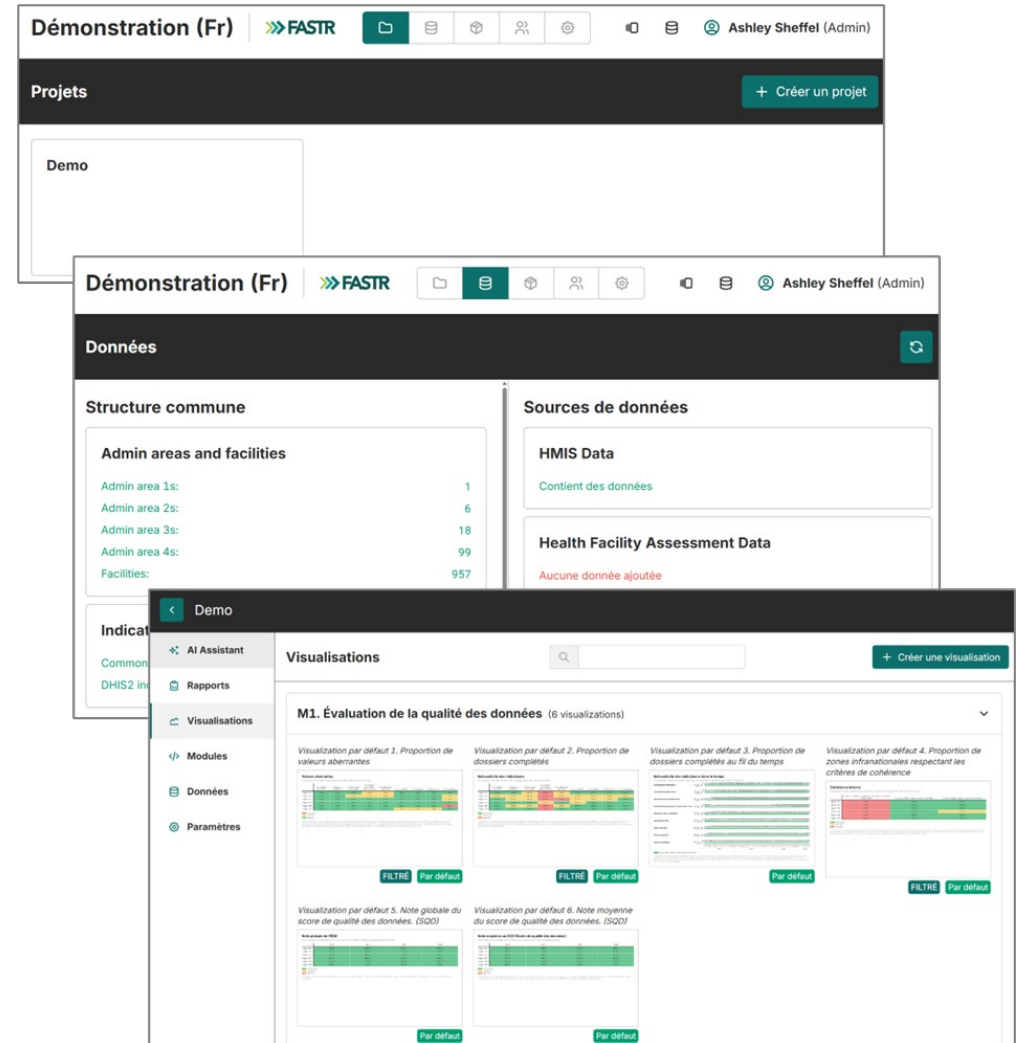
Save selection

Évaluation, ajustement et analyse de la qualité

Un **outil web** pour évaluer, ajuster et analyser la qualité des données de routine.

Importer et analyser des données de sources variées, dont DHIS2, avec des méthodes statistiques intégrées.

Une interface conviviale, et des options souples pour visualiser et exporter les résultats.



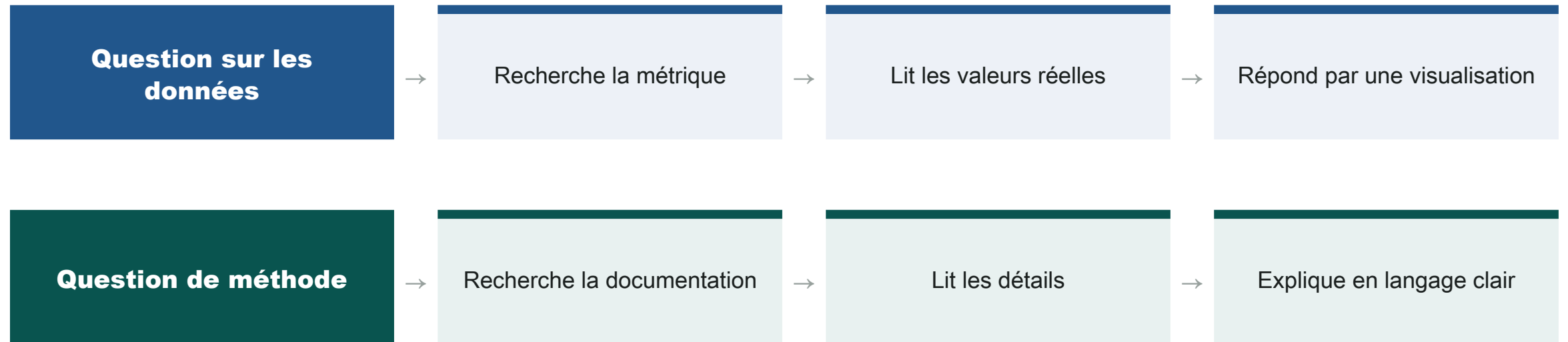
L'assistant IA

La plateforme comprend un **assistant IA** qui aide, à la demande, à interpréter les données et à générer des rapports.

- De nombreux systèmes de santé ont plus de données que de capacités pour les analyser.
- Le personnel de S&E dispose souvent de peu de temps pour des analyses approfondies.
- Les compétences analytiques varient selon les équipes et les régions.
- Transformer des données en récits demande des connaissances techniques et contextuelles.

Comment fonctionne l'assistant IA

L'IA suit le principe « **lire avant de répondre** » — elle ne devine jamais.



Un accélérateur, pas un décideur

Vous gardez le contrôle

- **Jugement** — décider ce qui est important
- **Interprétation** — comprendre le contexte
- **Action** — prendre les décisions

Assistant générique

Interroge le web ; pas nécessairement ancré dans les données et les méthodes d'un projet

L'IA interprète et explique

- Les chiffres viennent de **méthodes validées** : détection des valeurs aberrantes, estimations de couverture, scores de qualité
- Ces calculs utilisent des **formules statistiques éprouvées**, pas l'IA
- À vous de décider et d'agir

Assistant FASTR

Ancré dans les données et les méthodes du projet, il vérifie la source avant de répondre

La plateforme FASTR, en direct

Passons à la plateforme pour voir le flux de bout en bout :

- Importer les données depuis DHIS2 et parcourir les indicateurs
- Lancer une analyse et explorer les visualisations (qualité, volumes, couverture)
- Interroger l'assistant IA sur un résultat, puis générer un extrait de rapport

L'approche FASTR

Analyser • Apprendre • Renforcer • Agir



FASTR

Useful Data



GLOBAL
FINANCING
FACILITY



SUPPORTED BY
WORLD BANK GROUP